Neuenda Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.º 1 (2026) · pp. 7–19
CC BY-NC 4.0

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN · DOCENTES INVESTIGADORES

Sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de población adulta de Santa Cruz de la Sierra: estudio descriptivo exploratorio

Stress, anxiety, and depression symptoms in a sample of adults from Santa Cruz de la Sierra: A descriptive exploratory study

Regina Ninoska Ocampo Barba[1*]

[1] Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
* Correspondencia: regina.ocampo@uagrm.com.bo

RESUMEN

Objetivo. Describir la frecuencia y los niveles de gravedad de la sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de adultos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y explorar diferencias según sexo y grupo etario. Método. Estudio transversal descriptivo-exploratorio con muestreo no probabilístico por conveniencia en una campaña comunitaria de salud mental. De 1026 personas reclutadas, la muestra final fue de 746 adultos de 18 a 90 años; 712 completaron la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21). Se calcularon frecuencias, intervalos de confianza al 95 % por el método de Wilson y pruebas de chi-cuadrado con V de Cramér. Resultados. El 60,11 % de los participantes presentó puntuaciones de ansiedad por encima del rango normal, el 53,37 % de depresión y el 29,92 % de estrés; el 47,19 % alcanzó niveles de ansiedad moderados o superiores. La gravedad de la ansiedad se asoció con el sexo (mayor en mujeres; V = ,15), pero no la de la depresión ni la del estrés. El grupo de 18 a 25 años presentó mayor gravedad que el de 26 a 59 años en ansiedad y depresión (V = ,18 y ,16) y, en menor medida, en estrés (V = ,09). Conclusiones. En esta muestra de voluntarios, con predominio de mujeres y jóvenes, la ansiedad fue la sintomatología más frecuente y grave. Los resultados no son generalizables y deben contrastarse con diseños probabilísticos; orientan, de forma preliminar, estrategias preventivas para jóvenes y mujeres.

Palabras clave: ansiedad; depresión; estrés psicológico; DASS-21; salud mental comunitaria

ABSTRACT

Objective. To describe the frequency and severity of stress, anxiety, and depression symptoms in a sample of adults from Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, and to explore differences by sex

and age group. Method. Cross-sectional descriptive-exploratory study with non-probability convenience sampling in a community mental health campaign. Of 1,026 recruited individuals, the final sample comprised 746 adults aged 18 to 90 years; 712 completed the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Frequencies, 95 % Wilson confidence intervals, and chi-square tests with Cramér's V were computed. Results. Overall, 60.11 % of participants scored above the normal range for anxiety, 53.37 % for depression, and 29.92 % for stress; 47.19 % reached moderate or higher anxiety levels. Anxiety severity was associated with sex (higher in women; V = .15), whereas depression and stress severity were not. Participants aged 18 to 25 showed greater severity than those aged 26 to 59 in anxiety and depression (V = .18 and .16) and, to a lesser extent, in stress (V = .09). Conclusions. In this volunteer sample, predominantly composed of women and young people, anxiety was the most frequent and severe symptom dimension. Results cannot be generalized and should be tested with probabilistic designs; they provide preliminary guidance for preventive strategies for young people and women.

Keywords: anxiety; depression; psychological stress; DASS-21; community mental health

RECIBIDO
16 de julio de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Ocampo Barba, R. N. (2026). Sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de población adulta de Santa Cruz de la Sierra: estudio descriptivo exploratorio. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 7–19.

INTRODUCCIÓN

La salud mental constituye uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial, por el incremento sostenido de los trastornos emocionales y su impacto sobre la calidad de vida, el desempeño académico y laboral y el funcionamiento social de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2025) estima que aproximadamente una de cada ocho personas en el mundo vive con un trastorno mental, y que los trastornos de ansiedad y depresivos son los más frecuentes: alrededor de 301 millones de personas presentan trastornos de ansiedad y 280 millones viven con depresión, una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. En América Latina, la revisión sistemática y metaanálisis de Errazuriz et al. (2023) documentó una prevalencia elevada de trastornos depresivos en la población adulta de la región, lo que pone de relieve la necesidad de sistemas de vigilancia que permitan conocer la magnitud de estas condiciones en contextos específicos.

Desde la neuropsicología contemporánea, existe amplia evidencia de que el estrés, la ansiedad y la depresión comparten mecanismos neurofuncionales relacionados con la regulación emocional, el control ejecutivo y la adaptación al entorno. Estas condiciones se asocian con alteraciones funcionales en los circuitos frontolímbicos, particularmente en la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cingu-

lada anterior, la amígdala y el hipocampo, estructuras implicadas en la regulación de las emociones, la memoria, la atención y la toma de decisiones (Etkin et al., 2015; Ochsner et al., 2012; Pessoa, 2017).

Desde la neuropsicología de la regulación emocional, se ha propuesto que el malestar emocional sostenido refleja una desregulación en los sistemas frontolímbicos que subyacen al control cognitivo y a la respuesta afectiva (Etkin et al., 2015; Ochsner et al., 2012). La corteza prefrontal dorsolateral ejerce un papel modulador sobre estructuras subcorticales como la amígdala, el hipocampo y el estriado ventral, lo que permite la regulación de las emociones, la reevaluación cognitiva y la inhibición de respuestas automáticas ante estímulos amenazantes (Pessoa, 2017). Cuando este control descendente se ve comprometido —por estrés crónico, factores genéticos o experiencias adversas tempranas—, se produce una hiperreactividad amigdalina y una disminución de la conectividad funcional prefrontal que facilitan la aparición de síntomas ansiosos, depresivos y de tensión psicofisiológica (Arnsten, 2009; Etkin et al., 2015). El estrés prolongado activa, además, el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, eleva los niveles de cortisol y altera la plasticidad sináptica en regiones como el hipocampo, con efectos sobre la memoria, la atención y la regulación emocional (McEwen, 2017).

A partir de esta evidencia, la autora propone el Proceso de Desregulación Neuropsicológica (PDN) como marco conceptual exploratorio para comprender la interacción entre estrés, ansiedad y depresión. El PDN se fundamenta en dos postulados. El primero plantea que estas tres condiciones no son fenómenos independientes, sino manifestaciones interrelacionadas de un proceso progresivo de desregulación de los mecanismos responsables de la regulación emocional, el control ejecutivo y la adaptación al estrés, en coherencia con la evidencia de patrones compartidos de hiperreactividad amigdalina, disminución del control inhibitorio prefrontal y alteraciones de la conectividad frontolímbica (Etkin et al., 2015; Pessoa, 2017). El segundo sostiene que las manifestaciones subjetivas de estrés, ansiedad y depresión podrían funcionar como indicadores tempranos de ese proceso e identificarse mediante instrumentos estandarizados antes del establecimiento de trastornos clínicamente diagnosticables, en consonancia con las recomendaciones de la OMS (2025) sobre prevención y atención temprana. El PDN es un modelo teórico en desarrollo y no un constructo validado: el presente estudio no mide indicadores neurofuncionales ni pone a prueba sus postulados, por lo que el modelo se emplea aquí solo como marco interpretativo y sus implicaciones deben entenderse como hipótesis.

La Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés de 21 ítems (DASS-21) ha mostrado propiedades psicométricas adecuadas en muestras clínicas y comunitarias, con coeficientes de consistencia interna superiores a 0,80 (Antony et al., 1998; Lovibond y Lovibond, 1995), lo que la hace útil para estudios descriptivos y comunita-

rios. En el presente estudio se emplea para identificar manifestaciones subjetivas de estrés, ansiedad y depresión, sin que ello constituya un diagnóstico clínico ni neuropsicológico.

En Bolivia, y particularmente en Santa Cruz de la Sierra, la información sobre sintomatología emocional en población general es limitada, y la ausencia de registros sistemáticos dificulta la planificación de intervenciones basadas en evidencia (Aguilar, 2013). Disponer de información local, aunque sea de alcance descriptivo y con limitaciones muestrales, constituye un insumo para orientar programas preventivos y futuras investigaciones.

En respuesta a esta necesidad, el presente estudio tuvo como objetivo describir la frecuencia y los niveles de gravedad de la sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de población adulta de Santa Cruz de la Sierra, y explorar diferencias según sexo y grupo etario. El diseño transversal y el muestreo no probabilístico limitan la generalización de los resultados; se espera que esta aproximación exploratoria oriente investigaciones posteriores con diseños más sólidos.

MÉTODO

Diseño

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo-exploratorio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023). Según la clasificación de Ato et al. (2013), corresponde a un estudio descriptivo mediante encuesta de tipo transversal. Las variables se observaron sin manipulación, la información se recolectó en un único momento y el propósito fue caracterizar la frecuencia y la distribución de la sintomatología en la muestra, sin establecer relaciones causales. Aunque se enmarca en un contexto comunitario, el estudio no cumple los requisitos de un tamizaje poblacional, que exige muestreo probabilístico y representatividad, por lo que sus resultados describen únicamente a la muestra evaluada.

Participantes

La población de referencia estuvo constituida por personas adultas residentes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que participaron voluntariamente en una campaña comunitaria de salud mental organizada por el Instituto de Neurociencias Comportamentales (INCC) durante la gestión 2025. La muestra se seleccionó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia e incorporó a todas las personas que aceptaron participar y cumplieron los criterios de inclusión: edad igual o mayor a 18 años, residencia en Santa Cruz de la Sierra y firma del consentimiento informado. Se excluyó a quienes rechazaron o retiraron el consentimiento y a

quienes no podían responder el instrumento por limitaciones cognitivas, sensoriales o lingüísticas.

Inicialmente se reclutaron 1026 personas mediante convocatoria abierta. Tras la depuración de la base de datos se excluyeron 280 registros por cuestionarios incompletos (más del 10 % de ítems omitidos), patrones de respuesta inconsistentes (por ejemplo, marcación uniforme), duplicados, incumplimiento de los criterios de elegibilidad, ausencia de consentimiento informado o errores de digitación no verificables. La muestra final quedó constituida por 746 participantes, de 18 a 90 años, cuya composición se presenta en la Tabla 1. De ellos, 34 (4,56 %) no tenían respuestas registradas en la DASS-21, por lo que los análisis de sintomatología se basan en 712 participantes.

Tabla 1

Características sociodemográficas de la muestra

Variable	Categoría	*n*	%
Sexo	Femenino	486	65,15
	Masculino	247	33,11
	Prefiere no decirlo	13	1,74
Grupo etario	18 a 25 años	517	69,30
	26 a 59 años	215	28,82
	60 años o más	14	1,88

Nota. N = 746. Rango de edad: 18 a 90 años.

La muestra presenta una sobrerrepresentación de mujeres y de personas jóvenes, lo que limita su representatividad y debe considerarse al interpretar los resultados.

Instrumento

Se utilizó la Depression Anxiety Stress Scales de 21 ítems (DASS-21), versión abreviada de la DASS-42 desarrollada por Lovibond y Lovibond (1995). Es un autoinforme que evalúa la frecuencia e intensidad de síntomas emocionales experimentados durante la última semana mediante tres subescalas de siete ítems: estrés (tensión, irritabilidad, dificultad para relajarse), ansiedad (activación autonómica, miedo, pánico) y depresión (anhedonia, ánimo bajo, desesperanza, baja autoestima). Cada ítem se responde en una escala de cuatro opciones, de 0 (*no me aplicó en absoluto*) a 3 (*me aplicó mucho o la mayor parte del tiempo*).

Tabla 2

Puntos de corte de la DASS-21 por nivel de gravedad

Nivel	Estrés	Ansiedad	Depresión
Normal	0–14	0–7	0–9
Leve	15–18	8–9	10–13

Nivel	Estrés	Ansiedad	Depresión
Moderado	19–25	10–14	14–20
Severo	26–33	15–19	21–27
Extremadamente severo	≥ 34	≥ 20	≥ 28

Nota. Adaptado de Lovibond y Lovibond (1995). Las puntuaciones corresponden a la suma de cada subescala multiplicada por dos.

Procedimiento

El estudio se desarrolló en cuatro etapas. En la primera se elaboró el protocolo (diseño, criterios de selección, instrumento, procedimiento y plan de análisis), se organizó la campaña comunitaria y se capacitó al equipo evaluador del INCC en los objetivos del estudio, la administración estandarizada de la DASS-21, los principios éticos y el registro de la información. En la segunda se realizó la convocatoria abierta, se informó a los participantes sobre los objetivos, el carácter voluntario, la confidencialidad y el uso científico de la información, se obtuvo su consentimiento informado por escrito y se aplicó, de forma presencial y autoadministrada bajo supervisión, una ficha sociodemográfica y la DASS-21. En la tercera se registraron y codificaron los datos y se depuró la base de datos con los criterios señalados. En la cuarta se realizaron los análisis estadísticos y la interpretación de los resultados.

Análisis de datos

Los datos se procesaron con SPSS versión 26 y Microsoft Excel. Se calculó el coeficiente alfa de Cronbach para la escala global y para cada subescala; la muestra se describió mediante frecuencias y porcentajes. Para cada subescala se calculó la frecuencia de sintomatología positiva (puntuación superior al rango normal) con su intervalo de confianza al 95 % por el método de Wilson (Newcombe, 1998), y se describió la distribución por niveles de gravedad. La asociación entre la gravedad y las variables sexo y grupo etario se exploró mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson, con V de Cramér como tamaño del efecto y $\alpha = ,05$. Para cumplir el supuesto de frecuencias esperadas suficientes (Field, 2018), los análisis por sexo se limitaron a mujeres y varones (se excluyó la categoría “prefiere no decirlo”, $n = 13$) y los análisis por edad compararon los grupos de 18 a 25 y de 26 a 59 años (se excluyó el grupo de 60 años o más, $n = 14$, que se describe solo de forma descriptiva).

Consideraciones éticas

La investigación se rigió por los principios de la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013) y la normativa boliviana sobre investigación con seres humanos. Todos los participantes otorgaron su consentimiento informado por escrito; la participación fue voluntaria, con posibilidad de retiro en cualquier momento, y los datos se anonimizaron y almacenaron con acceso restringido al equi-

po investigador. Se ofreció a los participantes información sobre sus resultados y orientación para la derivación a servicios de salud mental cuando se identificaron niveles de gravedad clínica, y se dispuso de un protocolo de contención para atender la incomodidad emocional que pudiera surgir al responder. Tambien cabe mencionar que no existe financiamiento externo para la investigacion, al igual que no existe conflicto de intereses de parte del autor al respecto. Sobre la metodologia y analisis fue realizado de manera individual por el autor.

RESULTADOS

Frecuencia de sintomatología

La Tabla 3 presenta la frecuencia de participantes con puntuaciones superiores al rango normal en cada subescala y la distribución por niveles de gravedad. La ansiedad fue la dimensión con mayor frecuencia de sintomatología positiva, presente en seis de cada diez participantes, seguida por la depresión y el estrés. La ansiedad concentró también la mayor proporción de casos en niveles moderados o superiores (47,19 %; IC 95 % [43,55; 50,86]), frente al 28,93 % en depresión (IC 95 % [25,72; 32,37]) y el 8,57 % en estrés (IC 95 % [6,73; 10,85]). No se registraron niveles severos ni extremadamente severos de estrés, ni niveles extremadamente severos de depresión.

Tabla 3

Frecuencia de sintomatología positiva y distribución por niveles de gravedad en la DASS-21

Indicador	Estrés *n* (%)	Ansiedad *n* (%)	Depresión *n* (%)
Normal	499 (70,08)	284 (39,89)	332 (46,63)
Leve	152 (21,35)	92 (12,92)	174 (24,44)
Moderado	61 (8,57)	215 (30,20)	181 (25,42)
Severo	0 (0,00)	97 (13,62)	25 (3,51)
Extremadamente severo	0 (0,00)	24 (3,37)	0 (0,00)
Sintomatología positiva	213 (29,92)	428 (60,11)	380 (53,37)
IC 95 % de la sintomatología positiva	[26,67; 33,38]	[56,47; 63,65]	[49,70; 57,01]

Nota. n = 712 participantes con respuestas válidas en la DASS-21 (34 sin respuesta). Sintomatología positiva = puntuación superior al rango normal. IC 95 % calculado por el método de Wilson. Porcentajes calculados sobre los 712 casos válidos.

Diferencias según sexo

La Tabla 4 presenta la distribución de la gravedad según sexo. En estrés, la proporción en el rango normal fue similar en mujeres (68,14 %) y varones (73,28 %). En ansiedad, solo el 35,18 % de las mujeres se situó en el rango normal, frente al 48,99 % de los varones, y las mujeres presentaron mayores proporciones en los niveles moderado (32,96 % frente a 25,10 %), severo (14,60 % frente a 10,53 %) y extrema-

damente severo (4,42 % frente a 1,62 %). En depresión, el 44,69 % de las mujeres y el 51,82 % de los varones se situaron en el rango normal.

Tabla 4

Distribución de los niveles de gravedad de la DASS-21 según sexo

Dimensión y nivel	Mujeres *n* (%)	Varones *n* (%)
Estrés		
Normal	308 (68,14)	181 (73,28)
Leve	104 (23,01)	46 (18,62)
Moderado	40 (8,85)	20 (8,10)
Ansiedad		
Normal	159 (35,18)	121 (48,99)
Leve	58 (12,83)	34 (13,77)
Moderado	149 (32,96)	62 (25,10)
Severo	66 (14,60)	26 (10,53)
Extremadamente severo	20 (4,42)	4 (1,62)
Depresión		
Normal	202 (44,69)	128 (51,82)
Leve	115 (25,44)	57 (23,08)
Moderado	121 (26,77)	53 (21,46)
Severo	14 (3,10)	9 (3,64)

Nota. Mujeres con respuestas válidas, $n = 452$; varones, $n = 247$. Los 34 registros sin respuesta correspondían a mujeres. Se omite la categoría "prefiere no decirlo" ($n = 13$) y los niveles sin casos.

Diferencias según grupo etario

El grupo de 18 a 25 años presentó las mayores proporciones de sintomatología en las tres dimensiones (Tabla 5). En ansiedad, el 34,70 % de los jóvenes se situó en el rango normal, frente al 50,71 % del grupo de 26 a 59 años, y los niveles severo y extremadamente severo fueron más frecuentes en los jóvenes (15,20 % y 4,31 %). En depresión, la proporción en el rango normal fue del 41,27 % en jóvenes y del 57,82 % en el grupo de 26 a 59 años. En estrés, el rango normal agrupó al 67,56 % de los jóvenes y al 76,78 % del grupo de 26 a 59 años. El grupo de 60 años o más ($n = 14$) se describe solo a título informativo: ocho de sus integrantes se situaron en el rango normal de estrés y de ansiedad, y nueve en el de depresión.

Tabla 5

Distribución de los niveles de gravedad de la DASS-21 según grupo etario

Dimensión y nivel	18 a 25 años *n* (%)	26 a 59 años *n* (%)	60 años o más *n*
Estrés			
Normal	329 (67,56)	162 (76,78)	8
Leve	110 (22,59)	36 (17,06)	6
Moderado	48 (9,86)	13 (6,16)	0

Dimensión y nivel	18 a 25 años *n* (%)	26 a 59 años *n* (%)	60 años o más *n*
Ansiedad			
Normal	169 (34,70)	107 (50,71)	8
Leve	59 (12,11)	31 (14,69)	2
Moderado	164 (33,68)	48 (22,75)	3
Severo	74 (15,20)	22 (10,43)	1
Extremadamente severo	21 (4,31)	3 (1,42)	0
Depresión			
Normal	201 (41,27)	122 (57,82)	9
Leve	132 (27,10)	39 (18,48)	3
Moderado	133 (27,31)	47 (22,27)	1
Severo	21 (4,31)	3 (1,42)	1

Nota. Respuestas válidas: 18 a 25 años, $n = 487$; 26 a 59 años, $n = 211$; 60 años o más, $n = 14$. Por el tamaño reducido del grupo de 60 años o más no se calculan porcentajes.

Análisis de asociación

La Tabla 6 resume las pruebas de chi-cuadrado. La gravedad de la ansiedad se asoció significativamente con el sexo, con un tamaño del efecto pequeño; la de la depresión y la del estrés, no. Según el grupo etario, la gravedad de la ansiedad y de la depresión se asoció significativamente con la edad, con tamaños del efecto pequeños, y la del estrés mostró una asociación significativa de magnitud muy pequeña.

Tabla 6

Pruebas de chi-cuadrado entre los niveles de gravedad de la DASS-21, el sexo y el grupo etario

Cruce	χ^2	*gl*	*p*	*V* de Cramér	*n*
Sexo × estrés	2,14	2	,343	,06	699
Sexo × ansiedad	16,66	4	,002	,15	699
Sexo × depresión	4,04	3	,257	,08	699
Grupo etario × estrés	6,23	2	,044	,09	698
Grupo etario × ansiedad	22,10	4	< ,001	,18	698
Grupo etario × depresión	18,20	3	< ,001	,16	698

Nota. Sexo: mujeres y varones. Grupo etario: 18 a 25 y 26 a 59 años. Los valores se calcularon a partir de las frecuencias de las Tablas 4 y 5; ninguna celda tuvo frecuencia esperada inferior a 5.

DISCUSIÓN

El presente estudio se propuso describir la frecuencia y los niveles de gravedad de la sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de adultos de Santa Cruz de la Sierra y explorar diferencias según sexo y grupo etario. La ansiedad fue la dimensión con mayor frecuencia de sintomatología positiva (60,11 %), seguida por la depresión (53,37 %) y el estrés (29,92 %). Este orden coincide con la literatura que sitúa a la ansiedad entre las manifestaciones psicológicas más frecuentes en población general (Chacón Delgado et al., 2021; OMS, 2022).

Las frecuencias observadas son, sin embargo, considerablemente más altas que las prevalencias de trastornos estimadas en estudios epidemiológicos representativos. La OMS (2022) estima que los trastornos de ansiedad afectan aproximadamente al 4 % de la población mundial y los depresivos a cerca del 3,8 %, y el metaanálisis de Errazuriz et al. (2023) informa prevalencias de trastornos depresivos muy inferiores a las aquí observadas. La discrepancia puede atribuirse a varios factores: (a) la DASS-21 mide sintomatología, incluida la subclínica, y no trastornos diagnosticados; (b) la muestra está compuesta mayoritariamente por jóvenes y mujeres, grupos que en este estudio presentaron mayor gravedad, y (c) el reclutamiento por autoselección en una campaña de salud mental pudo atraer a personas con mayor malestar emocional, lo que sesgaría al alza las estimaciones. Por ello, las cifras no deben interpretarse como prevalencias poblacionales.

Las mujeres presentaron mayor gravedad de ansiedad que los varones, con un tamaño del efecto pequeño (V = ,15). Este patrón es consistente con la mayor prevalencia de trastornos internalizantes en mujeres documentada en la literatura (American Psychiatric Association [APA], 2022). En cambio, las diferencias en depresión y estrés según sexo no fueron estadísticamente significativas en esta muestra. Con la información disponible no es posible distinguir entre las explicaciones biológicas, psicológicas y sociales propuestas para esta diferencia, que no fueron evaluadas.

En cuanto a la edad, el grupo de 18 a 25 años presentó mayor gravedad que el de 26 a 59 años en ansiedad (V = ,18) y en depresión (V = ,16), y una diferencia de magnitud muy pequeña en estrés (V = ,09). Este hallazgo es coherente con los datos de UNICEF (2022) sobre la elevada frecuencia de angustia, depresión y ansiedad en adolescentes bolivianos, y sugiere la necesidad de fortalecer la promoción y la prevención en instituciones educativas y otros espacios comunitarios frecuentados por jóvenes. Las explicaciones habitualmente propuestas —transición a la vida adulta, presión académica y laboral, incertidumbre sobre el futuro— no fueron evaluadas en este estudio. El tamaño reducido del grupo de 60 años o más impide cualquier comparación con ese segmento.

Desde el marco del PDN, la coexistencia de sintomatología ansiosa y depresiva en una misma muestra y su mayor concentración en los grupos más jóvenes son compatibles con la hipótesis de un continuo de desregulación emocional; sin embargo, el diseño no permite contrastar esa hipótesis, porque no se midieron indicadores neurofuncionales ni se examinó la covariación entre subescalas.

Implicaciones teóricas y prácticas

En el plano teórico, el estudio aporta datos descriptivos locales que permiten formular hipótesis contrastables desde el PDN, por ejemplo, sobre la covariación entre las tres subescalas y su relación con medidas de control ejecutivo, en estudios

que incluyan indicadores neuropsicológicos. En el plano práctico, la alta frecuencia de sintomatología ansiosa y depresiva, en su mayor parte en niveles leves y moderados, sugiere la pertinencia de intervenciones preventivas universales y selectivas en espacios comunitarios y educativos, con énfasis en la población joven y, en el caso de la ansiedad, en las mujeres, así como la utilidad de la DASS-21 como instrumento de orientación para la derivación a evaluaciones clínicas.

Limitaciones

Los resultados deben interpretarse a la luz de las siguientes limitaciones: (a) el muestreo no probabilístico por conveniencia y la autoselección de los participantes impiden generalizar los resultados a la población de Santa Cruz de la Sierra; (b) la sobrerrepresentación de jóvenes y mujeres puede haber elevado las estimaciones globales; (c) el diseño transversal impide establecer trayectorias o relaciones causales; (d) el autoinforme está sujeto a sesgos de deseabilidad social, memoria y estado emocional; (e) el contexto de una campaña de salud mental pudo influir en la disposición a participar y en las respuestas, y (f) los análisis por sexo y por edad excluyeron a los grupos con frecuencias insuficientes (“prefiere no decirlo” y 60 años o más), sobre los que no pueden extraerse conclusiones.

CONCLUSIONES

En la muestra evaluada, la ansiedad fue la sintomatología más frecuente (60,11 %), seguida por la depresión (53,37 %) y el estrés (29,92 %), y fue también la que alcanzó mayor gravedad: el 47,19 % de los participantes presentó niveles de ansiedad moderados o superiores.

Las mujeres presentaron mayor gravedad de ansiedad que los varones, mientras que en depresión y estrés no se observaron diferencias significativas según sexo. El grupo de 18 a 25 años presentó mayor gravedad que el de 26 a 59 años en ansiedad y depresión y, en menor medida, en estrés. Todos los tamaños del efecto fueron pequeños.

Estos resultados describen a una muestra de voluntarios con predominio de mujeres y jóvenes y no son generalizables a la población. Constituyen una aproximación inicial que puede orientar investigaciones con muestreo probabilístico y diseños longitudinales, así como el diseño de estrategias preventivas en salud mental dirigidas a la población joven.

En el ámbito de la formación profesional, se recomienda fortalecer la enseñanza de la psicopatología y de la evaluación psicológica con instrumentos estandarizados, como la DASS-21, para la detección temprana y la derivación oportuna en contextos comunitarios.

REFERENCIAS

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., y Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. *Psychological Assessment*, *10*(2), 176–181. https://doi.org/10.1037/1040-3590.10.2.176

Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, *10*(6), 410–422. https://doi.org/10.1038/nrn2648

Asociación Médica Mundial. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*, *310*(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053

Ato, M., López-García, J. J., y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, *29*(3), 1038–1059. https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511

Chacón Delgado, E., Xatruch De la Cera, D., Fernández Lara, M., y Murillo Arias, R. (2021). Generalidades sobre el trastorno de ansiedad. *Cúpula, 35*

Errazuriz, A., Avello-Vega, D., Ramirez-Mahaluf, J. P., Torres, R., Crossley, N. A., Undurraga, E. A., y Jones, P. B. (2023). Prevalence of depressive disorder in the adult population of Latin America: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Regional Health – Americas*, *26*, Artículo 100587. https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100587

Etkin, A., Büchel, C., y Gross, J. J. (2015). The neural bases of emotion regulation. *Nature Reviews Neuroscience*, *16*(11), 693–700. https://doi.org/10.1038/nrn4044

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE.

Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. P. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*.

Lovibond, S. H., y Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales* (2nd ed.). Psychology Foundation of Australia.

McEwen, B. S. (2017). Neurobiological and systemic effects of chronic stress. *Chronic Stress*, *1*. https://doi.org/10.1177/2470547017692328

Newcombe, R. G. (1998). Two-sided confidence intervals for the single proportion: Comparison of seven methods. *Statistics in Medicine*, *17*(8), 857–872. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0258(19980430)17:8<857::AID-SIM777>3.0.CO;2-E

Ochsner, K. N., Silvers, J. A., y Buhle, J. T. (2012). Functional imaging studies of emotion regulation: A synthetic review and evolving model of the cognitive control of emotion. *Annals of the New York Academy of Sciences*, *1251*(1), E1–E24. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2012.06751.x

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Informe mundial sobre la salud mental: Transformar la salud mental para todos*.

Organización Mundial de la Salud. (2025). *Trastornos mentales*. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders

Pessoa, L. (2017). A network model of the emotional brain. *Trends in Cognitive Sciences*, *21*(5), 357–371. https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.002

UNICEF. (2022, 11 de octubre). *Ocho de cada 10 adolescentes pasan angustia, depresión y ansiedad, pero no buscan apoyo psicológico* [Comunicado de prensa]. https://www.unicef.org/bolivia/

comunicados-prensa/ocho-de-cada-10-adolescentes-pasan-angustia-depresión-y-ansiedad-pero-no-buscan

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).